

LES TUMEURS DE L'OVAIRE

I. Introduction

Rappels

- Processus tumoral au dépend de l'ovaire :
 - Bénin, malin ou borderline
 - Primitif ou secondaire
 - D'aspect kystique, solide ou solido-kystique.
- On élimine: Les kystes du corps jaune, Le corps jaune gravidique, Les kystes fonctionnels
- Processus tumoral de l'ovaire: C'est une pathologie fréquente et complexe.
- La pathologie bénigne est la plus fréquente mais parfois est responsable d'une symptomatologie aigue.
- Le cancer de l'ovaire est de pronostic sévère:
 - 4ème cause de décès par cancer chez la femme (Après le cancer du sein, colon et poumon)
 - évolution silencieuse jusqu'à des stades avancés (3/4 des kc d'ovaire diagnostiqués au Stades IIIb ou VI)
 - Survie tous stades confondu
 - 90 % des cancers de l'ovaire = Cancers épithéliaux
- Le diagnostic clinique est difficile. La découverte est souvent fortuite. L'échographie pelvienne est capitale:
 - Elle doit chercher les signes d'organocité
 - Elle doit rechercher les signes de malignité
 - Elle doit éliminer une pathologie fonctionnelle

II. Epidémiologie :

- Âge moyen: 60 – 70 ans
- Le cancer de l'ovaire est une maladie des pays développés.
- PIC entre 60 et 70 ans
- Au Maroc = 3ème cancer gynécologique (Sein et col) En Europe:
- Les pays du nord: Incidence élevée
- Pays du sud: l'incidence est plus faible
- Aux USA : Première cause de mortalité par cancer chez la femme

III. FDR :

1. Facteurs de risque

a. Facteurs hormonaux:

- Rôle de l'ovulation:
 - Traumatismes répétés
 - Facteurs protecteurs: Anovulation
 - Facteurs de risque: Ovulation
- Age avancée à la première naissance: RR X 1,5 à 2 si grossesse après 25 ans
- Ménarches précoces, Ménopause tardive
- Infertilité: RR X 2,2 à 6 Inducteurs de l'ovulation
- Blocage de l'ovulation: = Facteur protecteur

Contraception oestro-progestative, grossesse, allaitement...etc.

b. Age : Incidence et mortalité du cancer de l'ovaire pour 100 000 femmes en fonction de l'âge

Age	Incidence	Mortalité
Moins de 20 ans	0.7	0.04
De 20 a 49 ans	6.6	2
De 50 a 64 ans	26.9	16
De 65 a 74 ans	48.6	36.1

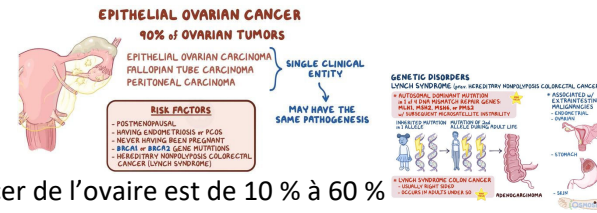
Plus de 75 ans 55.6 55.2

c. Facteurs non hormonaux:

- Niveau socio-économique élevé.
- Irradiation pelvienne.
- Expositions professionnelles (Amiante)...Etc.

d. Facteurs génétiques:

- 5 – 10 % surviennent dans un contexte familial
- Mutation du gène BRC A1; BRC A2 : Probabilité de développer un cancer de l'ovaire est de 10 % à 60 %
- Des cas familiaux de cancers de l'ovaire: Syndrome de Lynch: Association de cancers de l'ovaire, du sein, du colon, de l'endomètre



2. Facteurs protecteurs :

- Multiparité
- Contraception oestro-progestative
- Alimentation riche en anti-oxydants

Facteurs de risque	Facteurs de risque possibles	Facteurs protecteurs
Age > 50ans Tabagisme Antécédents familiaux de cancer de l'ovaire BRCA Antécédents personnels de cancer du sein Néoplasie, 1 ^{re} grossesse tardive Diagnose génétique Hormonothérapie substitutive, FIV Génétique : Mutation des gènes BRCA 1 et 2, Syndrome de Lynch	Obésité Endométriose	Multiparité Prise de contraceptifs oraux (à partir d'un oestro-progestatif pendant 5 à 10 ans diminue le risque de mortalité) Alimentation riche en végétaux

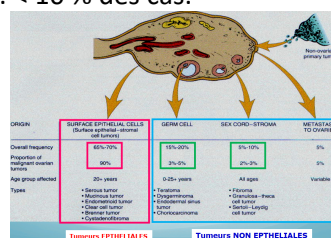
Facteurs favorisants	Facteurs protecteurs
Prédisposition génétique Nulliparité, Règles précoces Ménopause tardive Age	Contraception orale Grossesse Allaitement Ligature des trompes

IV. Classification anatomo-pathologique :

- C'est la classification de l'OMS; basée sur l'origine cellulaire présumée.
- L'ovaire est une glande mixte où on trouve: Un épithélium de surface; et des cellules germinales

1. Les tumeurs épithéliales:

- 70 % des tumeurs de l'ovaire. 80 % des tumeurs malignes de l'ovaire
- Plusieurs types histologiques et pour chaque type:
 - Bénins (60 % des cas) Malin (30 % des cas)
 - A la limite de la malignité (=Tumeurs borderlines): < 10 % des cas.
 - Tumeurs séreuses: Les plus fréquentes



Classification des tumeurs ovariennes selon l'OMS			
Tumeurs épithéliales 75 %			
Séreuses : cystadénome bénin, borderline (à la limite de la malignité) et tumeur séreuse invasive. Mucineuses : cystadénome de type endocervical ou intestinal, borderline mucineux, et tumeur mucineuse invasive. Endométriales : bénignes, borderlines et invasive À cellules claires : tumeur bénigne de Brenner, borderline, tumeur invasive de Brenner, carcinome à cellules transitionnelles Carcinomes épidermoïdes			
Tumeurs des cordons sexuels 5-10 %			
Granulosa-stroma : tumeur de la granulosa, tumeur de type fibrome-thecome Sertoli-stroma : androblastome, tumeur de la Sertoli-Leydig Tumeurs des cordons sexuels avec annulaires tubules Gynandroblastome Tumeur à cellules stéroïdales			
Tumeurs germinales 15-20 %			
Dysgerminome Tumeur du sac vitellin Carcinome embryonnaire Polymyome Choriocarcinome Tératomes : immature, mature, mixte			
Autres rares			
Gonadoblastomes Tumeur du rete ovarii Tumeurs mésothéliales Maladies trophoblastiques de l'ovaire Carcinome à petites cellules			

❖ Cystadénomes bénins

❖ Cystadénocarcinomes

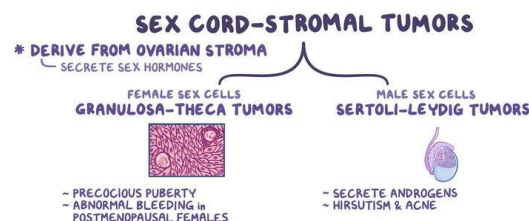
- Tumeurs endométriales
- Tumeurs mucineuses:
 - Cystadénome mucineux
 - Cystadénocarcinome mucineux
- Tumeurs de Brenner
- Tumeurs à cellules claires
- Carcinomes indifférenciés
- Tumeurs non classées

2. Les tumeurs du mésenchyme et des cordons sexuels : 6 à 8 % des cancers de l'ovaire, appelées:

- Tumeurs endocrines
- Tumeurs sécrétantes:
 - Estrogène = Tumeurs féminisantes
 - Androgènes = Tumeurs masculinisantes

a. Tumeurs des cordons sexuels:

- Tumeurs à cellules de la granulosa:
 - = Tumeurs féminisantes
 - Adultes ou juvéniles
 - Sécrètent des estrogènes
 - L'évolution est lente
 - Les récidives sont tardives (≈ 10 ans)
- Tumeurs à cellules de Sertoli et Leydig (Androblastomes):
 - = Tumeurs masculinisantes



ORIGINE	CELLULES ÉPITHÉLIALES (LÉ)	CELLULES GERMINALES (DIPLOCYTES)	STROMA ET CORDONS SEXUELS	MÉTASTASES
Sous-types*	Séreuses Mucineuses Endométriales Cellules claires Cellules transitionnelles	Tératome mature (95%) / immature Dysgerminome Tumeur du stroma endodermique Choriocarcinome	Fibrome / Fibrothécome Tumeurs thécales Tumeurs à cellules de Leydig / de Sertoli	Adénocarcinome mucineux bilatéral (ovaire, colon, appendice, estomac, sein)
Âge habituel	> 20 ans	0-20 ans	Tout âge	
Fréquence parmi les tumeurs de l'ovaire	65-70 %	15-20 %	5-10 %	5 %
Fréquence parmi les cancers de l'ovaire	90 %	3-5 %	2-3 %	5 %

- Responsables de signes de virilisation
- Signes cliniques et biologiques d'hyper-androgénie Les récives sont précoces
- Sont de mauvais pronostic

Autres tumeurs rares:

- Gynandroblastomes (Association de cellules de la granulosa et cellules de Sertoli)
- Tumeurs à cellules de Sertoli
- Tumeurs des cordons sexuels indifférenciés

b. Tumeurs du mésenchyme : Fibromes -Thécomes -Tumeurs fibro-techales -Fibrosarcomes

3. Les tumeurs germinales:

- Rares
- 30 % des tumeurs primitives de l'ovaire
- Dont 95 % sont des tumeurs tératomes mature (= Kystes dermoïdes bénins)
- 2 groupes:
 - Les dysgerminomes = Séminomes
 - Les tumeurs non dysgerminomateuses = Tumeurs non séminomateuses

a. Les dysgerminomes : Les plus fréquents des tumeurs germinales

b. Les tumeurs non dysgerminomateuses : Les tumeurs non tératomeuses:

- Les tumeurs vitellines:
 - Malignes,
 - Touchent la femme jeune Mauvais pronostic
 - Secrète l'α foeto-protéine (AFP)
- Le carcinome embryonnaire
- Le choriocarcinome pur non gestationnel
- Le polyembryome
- Les tumeurs du sinus endodermique....etc.

4. Les tumeurs secondaires: 6 – 10 % des tumeurs de l'ovaire = Métastases ovariennes = Tumeurs de

Krukenberg

V. Modes de dissémination : Capsule ovarienne = Barrière à l'extension péritonéale

1. La dissémination péritonéale:

- Péritoine viscéral:
 - Pelvien
 - Grande cavité péritonéale
 - Gouttières pariéto-coliques
 - Grand épiploon
 - Coupes diaphragmatiques

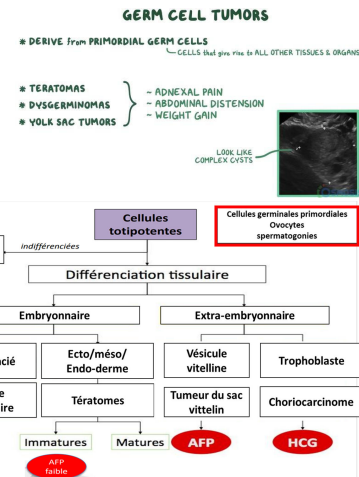
2. La dissémination sanguine:

- Métastases Hépatiques,
- Métastases Pleurales
- Métastases Pulmonaires
- Autres....etc.

3. La dissémination lymphatique

- Ganglions iliaques: primitif externe interne
- Ganglion lombo-aortique
- Ganglions inguinaux

VI. Diagnostic :



deux grands modes de dissémination

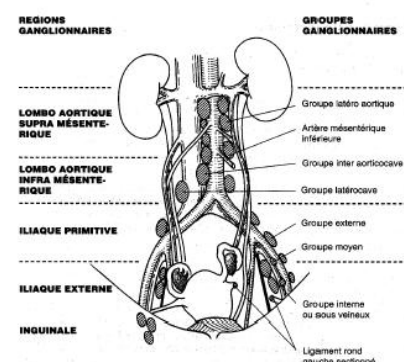
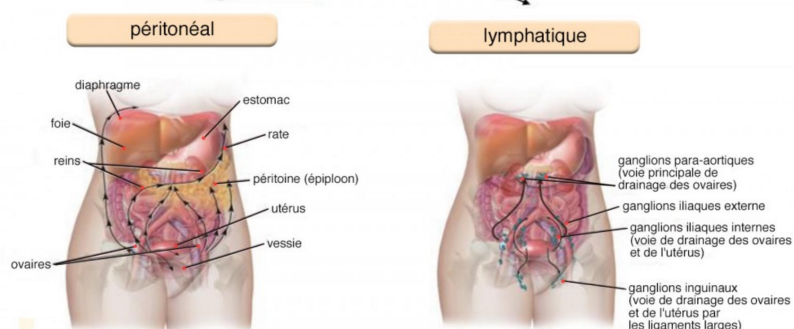


Fig. 2 Régions et groupes ganglionnaires

1. Diagnostic clinique:

- 75 % des cancers de l'ovaire sont diagnostic aux stades III et IV
- Aux stades précoces, le cancer de l'ovaire est asymptomatique: Le diagnostic est souvent FORTUIT.
- **a. Circonstances de diagnostic:**
 - Fortuite:
 - Exceptionnellement
 - Lors d'un examen gynécologique
 - Lors d'une échographie gynécologique.
 - Devant des signes cliniques
 - Du fait de la situation anatomique des ovaires: les tumeurs des ovaires peuvent atteindre un volume important avant de se manifester cliniquement.
 - Les signes cliniques peuvent-être très variés:
 - Mais: Aucun signe n'est spécifique
 - Parfois: Normal
 - Signes d'orientation digestive: syndrome tumoro-ascitique; augmentation du volume abdominal
 - Signes d'orientation pelvienne: pesanteur; douleurs pelviennes; métrorragies; signes de compression des organes de voisinage; œdème des membres inférieurs...etc.
 - Syndrome endocrinien: Signes de féminisation, masculinisation
 - Signes pulmonaires: Douleurs thoraciques, dyspnée...etc.
 - Syndrome abdominal aigu
 - Altération de l'état général

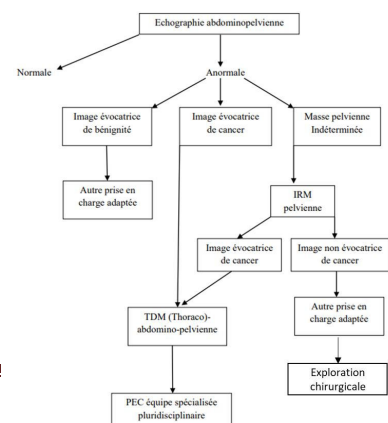
b. Examen clinique:

- Stades de début:
 - Parfois: Simple inconfort abdominal
 - Parfois:
 - Masse léro-utérine, kystique, solide, solido-kystique
 - Souvent : de petite taille, mobile, sans aucun autre signe accompagnateur
- Stades avancés :
 - Rechercher des signes de malignité, si présents ? stade avancé
 - En général: C'est une masse pelvienne ou abdomino-pelvienne
 - De consistance dure Fixée
 - Souvent bilatérale
 - Associée à une ascite (très évocatrice de malignité)

2. Diagnostic para-clinique :

a. Echographie pelvienne :

- Considérée comme un prolongement de l'examen clinique
- Pratique par voie sus-pubienne à vessie pleine ou par voie endo-vaginale à vessie vide
- C'est un examen opérateur dépendant
- Permet d'explorer: les ovaires; l'utérus; l'endomètre; la cavité péritonéale; le foie, les rein; les ganglions...etc.
- Souvent c'est une masse annexielle latéro-utérine
- Il faut préciser:
 - Sa localisation Sa taille
 - Sa forme
 - La notion de bilatéralité
 - La paroi: Epaisse, Vascularisation...etc.
 - Son écho-structure
 - La nature de la vascularisation au Doppler



Kystes ovaires OPERES



Gy



Devant une image latéro-utérine; il faut faire une différence entre une image de nature organique ou fonctionnelle.

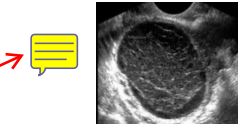
Les critères d'organicité:

- Image anéchogène avec des végétations.
- Image kystique de grand diamètre > 6 cm
- Présence d'une composante solide écho-gène
- Caractère multiloculaire.
- Paroi épaisse du kyste
- Présence d'une ascite associée.

Kystes fonctionnels



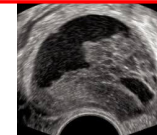
Kystes organiques



Devant une image latéro-utérine de nature organique; il faut chercher les signes de malignité

Les critères de malignité:

- Image hétérogène à double composante tissulaire et liquidienne: Les critères de malignité dépendent de la composante tissulaire.
- Taille augmentée > 10 cm
- Présence de végétations: Exo-kystiques, endo-kystiques
- Parois et cloisons épaisses, irrégulières et vascularisées au Doppler Contenu hétérogène
- Présence d'une ascite ou de métastase.



Malin	Bénin
- tumeur solide irrégulière - présence d'un épanchement péritonéal - présence d'au moins quatre végétations - tumeur irrégulière multiloculaire solide dont un des diamètres est supérieur à 10 cm - score colorimétrique fort	- kyste uniloculaire - présence de composantes solides dont le plus grand diamètre est inférieur à 7 mm - cône d'ombre - masse multiloculaire lisse avec un diamètre maximal inférieur à 100 mm - absence de flux en doppler couleur

	Kyste organique bénin	Kyste organique malin
Taille	< 10 cm	> 10 cm
Nombre	Unique	Multiloculaire
Contours	Régulier	Mal limités
Parois	Fines et régulières	Epaisses irrégulières
Cloison	Fines et régulières	Epaisses et vasculaires
Végétations	non	Oui
Contenu	anéchogène homogène hétérogène prédominance liquidienne	Hétérogène prédominance solide
Ascite	Non	Oui
Doppler couleur	Vascularisation périphérique	Vascularisation centrale
Doppler pulsé	Indexe de pulsabilité élevé	Indexe de pulsabilité faible



QE!!

b. Echographie Doppler : En complément à l'échographie pelvienne

IRM pelvienne : Examen de référence pour les tumeurs ovariennes

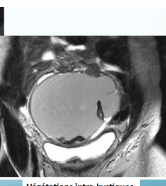
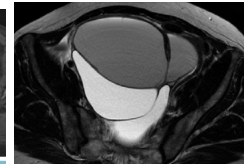
Intérêt:

- En cas de doute à l'échographie
- En cas de masse volumineuse

Objectifs de l'IRM:

- Caractériser la tumeur: composantes de la tumeur kystique ou tissulaire
- Origine ovarienne ou non
- Etablir un bilan d'opérabilité: recherche des signes d'extension locale
- Ganglions iliaque et lombo-aortiques

Classification ORADS



d. TDM :

- Abdomino-pelvien, Thoraco-abdomino-pelvien (TAP)
- Dans le cadre d'un bilan d'extension

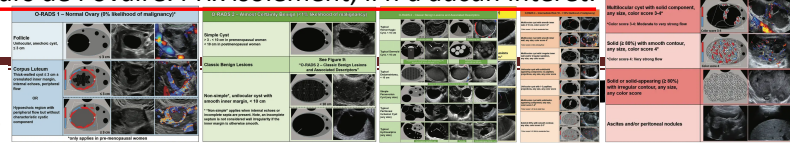
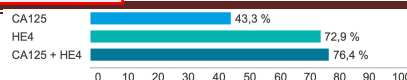
e. Les marqueurs tumoraux : Il y a plusieurs types de marqueurs:

- CA 125 (Carbohydre Antigène 125) : Adénocarcinomes séreux
- CA 19-9 et l'ACE (Antigène Carcino-Embryonnaire) : Tumeurs mucineuses.
- hCG et α FP (alpha-fœtoprotéine) : Tumeurs germinales

Le CA 125 est le marqueur le plus utilisé dans les tumeurs de l'ovaire. Prix isolément; il n'a aucun intérêt.

Le marqueur tumoral HE4:

Mehdi Alem



Le CA 125: Intérêts

- Il n'est ni spécifique, ni sensible
- Secrété dans d'autres situation: grossesse, pathologie hépato-biliaire; insuffisance rénale; endométriose...etc
- Son résultat doit toujours être couplé aux autres examens: Echographie, IRM
- Son rôle est:
 - Pronostic:
 - Un taux très élevé est un facteur de mauvais pronostic
 - Un taux en plateau sous chimiothérapie est un facteur de mauvaise réponse
 - Suivie post-traitement: un taux qui s'élève est un signe de récurrence ou de métastases

VII. Diagnostic différentiel :

1. Les tumeurs bénignes:

- **Kystes fonctionnels:**
 - Kystes folliculaires
 - Kystes du corps jaune gravidique
 - Syndrome d'hyperstimulation ovarienne
- **Kystes organiques:**
 - Kystes endométriosiques
 - Kystes dermoïdes
 - Tumeurs bénignes solides de l'ovaire: thécomes, fibromes

2. Les tumeurs d'autres origines:

- Tumeurs d'origine digestive:
- Tumeurs de l'arbre urinaire:
- Autres tumeurs d'origine gynécologique:
 - Kystes vestigiaux
 - Hydrosalpinx; pyosalpinx
 - Grossesse extra-utérine
 - Endométriomes ovariens
 - Nodules d'endométriose pelvienne
 - Fibromes en nécrobiose

VIII. Bilan d'extension :

1. Echographie abdominale:

- Métastases hépatiques
- Métastases épiploïques; pariétales
- Carcinose péritonéale
- Adénopathies profondes

2. Radiographie du poumon: Métastases pleurale et pulmonaire

3. TDM

- Abdomino-pelvienne
- Thoraco-abdomino-pelvienne
- Intérêt:
 - Bilan d'opérabilité: envahissement des organes de voisinages
 - Exploration des adénopathies profondes
 - Carcinose péritonéales Métastases hépatiques...etc.

TDM Thoraco-abdomino-pelvienne:



IX. Cas particuliers :

1. Tumeurs à malignité réduite:

- Appelée également:

- Tumeurs frontières de l'ovaire
- Tumeurs à la limite de la malignité
- Tumeurs à faible potentiel de malignité
- Décrites pour la première fois en 1929
- Représentent: 10 à 20 % des tumeurs épithéliales de l'ovaire
- Touchent la femme jeune (En général 10 ans plutôt que les carcinomes de l'ovaire).
- Bon pronostic: 95 % de survie à 5 ans (tous stades confondus) et 90 % de survie à 10 ans
- Elles sont diagnostiquées souvent aux stades de début
- Le diagnostic positif est anatomo-pathologique: caractérisé par une absence d'envahissement du stroma
- La prise en charge de ces tumeurs est la même que pour les tumeurs invasives.

2. Tumeurs de l'ovaire et grossesse:

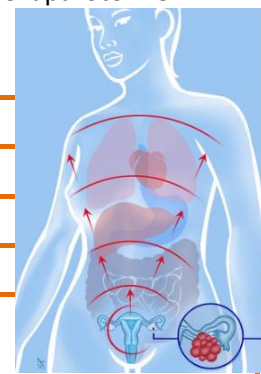
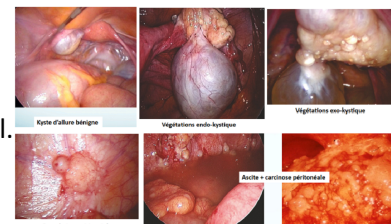
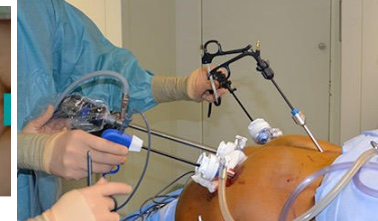
- Fréquence: 1/ 300 000
- Clinique + Echographie → Diagnostic
- Découverte est souvent fortuite par l'échographie

3. Tumeurs secondaires de l'ovaire = Métastases ovarienne = Tumeurs de Krukenberg

X. Traitement : ←

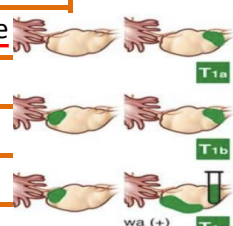
1. Classification:

- Elle est chirurgicale, par laparotomie ou par cœlioscopie
- Il faut faire une exploration totale: 
 - Cavité pelvienne, abdomino-pelvienne,
 - Péritoine,
 - Gouttières pariéto-coliques ,
 - Capsule hépatique, coupes diaphragmatiques..
- La prise en charge chirurgicale passe par une stadification chirurgicale peropératoire
- L'exploration par laparotomie est plus facile, et permet de faire le traitement chirurgical.
- L'exploration par cœlioscopie: 
 - Limitée aux petites tumeurs
 - Pas d'indication dans les tumeurs étendues avec une carcinose Permet d'éviter une laparotomie
 - Permet d'orienter la chirurgie
 - En cas de suspicion de malignité, une reconversion laparotomique s'impose  → 



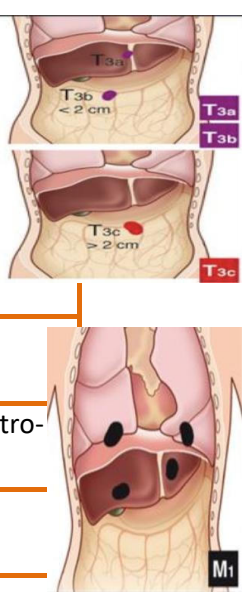
stade 4 : migration vers la plèvre, les poumons, le foie
 stade 3 : migration vers l'intestin, le colon, l'estomac et le diaphragme, le cœur
 stade 2 : migration vers l'utérus, les trompes, le rectum, la vessie
 stade 1 : extension du kyste cancéreux

TNM	FIGO	Description
Tx		Tumeur primitive non évaluable
T0		Pas de lésion ovarienne
<u>T1</u>	<u>Stade I</u>	<u>Tumeur limitée aux ovaires</u>
<u>T1a</u>	<u>I a</u>	<u>Un ovaire atteint, capsule intacte, pas de végétation externe ni d'ascite</u>
<u>T1b</u>	<u>Ib</u>	<u>Deux ovaires atteints, capsules intactes, pas de végétation externe; ni d'ascite</u>
<u>T1c</u>	<u>Ic</u>	<u>Limitée aux ovaires avec rupture capsulaire ou végétation externe ou ascite/ liquide de lavage péritonéal contenant des cellules néoplasiques.</u>
T2	Stade II	Tumeur ovarienne étendue aux autres organes pelviens
T2a	IIa	Extension à l'utérus et/ou aux trompe(s)
T2b	IIb	Extension aux autres organes pelviens,
T2c	IIc	IIA ou IIB avec végétations externes ou ascite ou liquide de lavage péritonéal contenant des cellules néoplasiques



3. Classifications 2018 FIGO et TNM (8^{ème} édition) des tumeurs épithéliales de l'ovaire, trompes et péritonéales primitives

Stade	TNM	Description
Stade I	T1	Tumeur limitée aux ovaires (T du 1 ^{er} ou 2 ^e)
Stade II	T2	Tumeur limitée à l'utérus et/ou aux trompes, sans extension à d'autres organes pelviens
Stade III	T3	Tumeur limitée aux ovaires, à l'utérus et/ou aux trompes, avec extension à d'autres organes pelviens
Stade IV	T4	Tumeur limitée aux ovaires, à l'utérus et/ou aux trompes, avec extension à d'autres organes pelviens



T 3	Stade III	Tumeur ovarienne étendue au péritoine extra-pelvien et/ou atteignant les ganglions rétro-péritonéaux ou inguinaux (métastases régionales)
T3a	IIla	Extension microscopique au péritoine abdominal
T3b	IIlb	Localisation(s) péritonéale(s) macroscopique(s) ≤ 2 cm de diamètre; ganglions négatifs
T3c et/ou N1	IIlc et IIc-g	Localisation(s) péritonéale(s) > 2 cm de diamètre et/ou atteinte d'un ganglion rétro-péritonéal ou inguinal
T4	Stade IV	Métastase à distance (pleurales*, hépatiques intra- parenchymateuses...) *Cytologie positive exigée pour un épanchement pleural.

2. Moyens thérapeutiques:

a. La chirurgie :

❖ Buts :

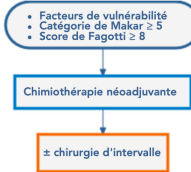
QE!!

Score de Fagotti

- Chirurgie : la base du TTT et doit-être le + large possible
- Elle commence par une exploration de toute la cavité abdomino-pelvienne pour:
 - Etablir une classification de la tumeur
 - Evaluer un pronostic
 - Guider le traitement chirurgical
- Toujours:
 - Faire une ponction pour une étude cytologique du liquide d'ascite
 - Un lavage aspiration de la cavité péritonéale
 - Des biopsies péritonéales multiples

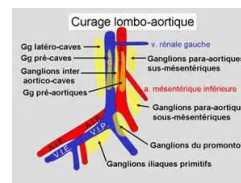
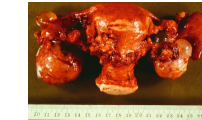
❖ Types :

- Intervention chirurgicale de base:
 - Hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale
 - Omentectomie
 - Curage ganglionnaire iliaque bilatérale et lombo-aortique
 - Appendicectomie (si tumeur mucineuse)
- Parfois:
 - Annexectomie unilatérale
 - Exérèses larges
 - Réduction tumorale
 - Résections anastomoses digestives
 - Dépéritonisations
 - Métastasectomie



Catégories de Makr

Bon état général
Catégorie de Makr < 5
Score de Fagotti < 8



Des scores: (Pour une meilleure prise en charge)

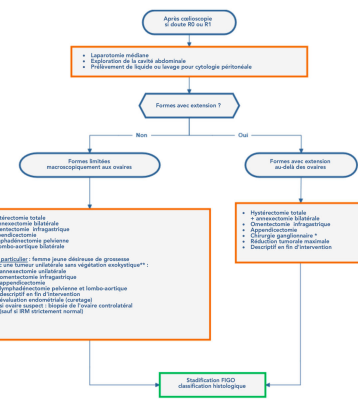
Paramètres	Score de Fagotti	Score
Gâteau épiploïque	0 : localisations isolées 2 : infiltration diffuse allant à la grande courbure de l'estomac	
Carcinose péritonéale	0 : carcinose atteignant des territoires limités (épigastriques, péri-ombilicales ou péritoine pelvien résectables chirurgicalement par laparotomie) 2 : infiltration péritonéale massive NON RESECCABLE ou distribution miliaire	
Carcinose diaphragmatique	0 : tous les autres cas 2 : infiltration large ou nodules confluent infiltrant la majeure partie de la surface diaphragmatique	
Rétraction mésentérique	0 : absence de rétraction mésentérique 2 : rétraction mésentérique	
Infiltration du tube digestif	0 : tous les autres cas 2 : une résection digestive est envisagée	
Infiltration de l'estomac	0 : tous les autres cas 2 : nodules infiltrant l'estomac et/ou rate et/ou petit épiploon	
Métastases hépatiques	0 : tous les autres cas 2 : toute lésion de surface > 2 cm	

→ Chaque item est coté de 0 à 2. Le score total, pouvant varier de 0 à 14, est obtenu en additionnant le score pour chaque atteinte prise en compte (score=0 si atteinte absente, score=2 si atteinte présente).
→ La chirurgie d'exérèse est incomplète chez 100 % des patientes dont le score est ≥ 8.

Des scores: (Pour une meilleure prise en charge)

Catégories de Makr	
Chirurgie initiale	Chirurgie initiale
Catégorie 1	• tumeur localisée au pelvis • peu ou pas d'ascite • pas de nécessité de résection digestive
Catégorie 2	• tumeur localisée au pelvis • peu ou pas d'ascite • une résection digestive est nécessaire
Catégorie 3	• tumeur en grande partie localisée à l'étage sus-mésocolique • peu ou pas d'ascite • pas de nécessité de résection digestive
Catégorie 4	• tumeur en grande partie localisée à l'étage sus-mésocolique • peu ou pas d'ascite • une résection digestive est nécessaire
Catégorie 5	• tumeur en grande partie localisée à l'étage sus-mésocolique • ascite abondante ou présence de miliary sur le mésentère • nécessité de plusieurs résections digestives

• Si le score de Makr est en catégorie 4 avec des facteurs de vulnérabilité ou en catégorie 5 ou si le score de Fagotti est ≥ 8 :
→ ne pas réaliser de chirurgie initiale.



Objectif final de la chirurgie: Absence de résidu tumoral (R 0)= Facteur pronostic

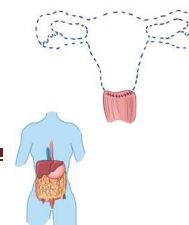
b. La chimiothérapie :

- Les tumeurs de l'ovaire sont chimiosensibles: Toujours en adjuvant
- Tumeurs épithéliales:
 - Plusieurs produits : Dérivés de taxanes, Cis-platinum, Cyclophosphamides; adriamycine...etc.
 - Protocoles : Taxol-Carboplatine; CP, CAP ...etc.
- Tumeurs germinales: Méthotrexate, Actinomycine; Vincristine; Bléomycine....etc.

c. La radiothérapie

3. Indications:

a. Les tumeurs épithéliales :



TOTAL ABDOMINAL HYSTERECTOMY & BILATERAL SALPINGO-OOPHORECTOMY
UTERUS, FALLOPIAN TUBES, & OVARIES REMOVED
PARAAORTIC LYMPH NODE DISSECTION
INFRAOORTIC or INFRAOORTIC OMENTECTOMY
PART of the GREATER OMENTUM REMOVED
LAPAROTOMY
CHECK for the PRESENCE of MALIGNANT CELLS
CAREFUL VISUAL INSPECTION of the ABDOMINAL ORGANS
BIOPSIES TAKEN from SUSPICIOUS AREAS

❖ Stade I a:

QE!!

• Femme jeune: traitement conservateur

- Ovariectomie simple homolatérale
- Eviter toute rupture accidentelle du kyste

• Mais:

- Risques de récurrence
- Il faut faire: Une biopsie controlatérale de l'ovaire; biopsies péritonéales, lavage aspiration du -péritoine pour un étude cytologique

QE!!

• Femme âgée: Traitement radical

❖ Stade I b, bien différencie de grade I :

• Traitement chirurgical SEUL: traitement conservateur

- Hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale; omentectomie; curage iliaque et lombo-aortique et appendicectomie si tumeur mucineuse
- Aucun traitement adjuvant
- Survie à 5 ans > 95 %

❖ Stade I b, de grade II ou III

• Traitement chirurgical : traitement conservateur

- Hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale; omentectomie; curage iliaque et lombo-aortique et appendicectomie si tumeur mucineuse
- Associée à une chimiothérapie

❖ Autres Stades :

• Chirurgie aussi large que possible et en fonction de l'état:

- Hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale; omentectomie; curage iliaque et lombo-aortique et appendicectomie si tumeur mucineuse
- Réductions tumorales
- Résections anastomoses

• Chimiothérapie

• Chirurgie de rattrapage si résidu de plus de 2 cm

b. Les autres types de tumeurs:

❖ Stades I a:

• Traitement conservateur si femme jeune

❖ Autres Stades:

- Tumeurs non séminomateuses: Traitement radical + chimiothérapie
- Tumeurs séminomateuses: Traitement radical + radiothérapie

c. Les tumeurs borderlines:

❖ Stades I a :

• Traitement conservateur si femme jeune

❖ Stades Ib; II a, II b :

• Traitement radical Seul

❖ Stades Ib; II a, II b :

- Traitement radical ou cytoréduction
- Chimiothérapie ????
- Chirurgie de rattrapage

XI. Surveillance :

- Elle est :
 - ✓ Clinique

- ✓ Echographique
- ✓ Marqueurs tumoraux
- ✓ TDM en fonction des signes cliniques; biologiques ou échographiques
- ✓ Aussi longtemps que possible

